

Fecha Última Actualización: 25-08-2023 17:04:28

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Claudio Antonio Casanova Solano
Edad : 50a 0m 20d
Dirección : Pje Guillermo M.2516 V Villorrio Pa

Rut : 12.502.972-8
Fecha Nacto: 05/08/1973
Comuna : Pirque

N° Archivo : 2210652
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 2009 6056

N° Epicrisis
366934

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Medicina Cuidados Básicos 5° Piso
Unidad de Egreso : Medicina Cuidados Básicos 5° Piso

Fecha Ingreso : 13/08/2023 21:50
Fecha Egreso : 25/08/2023 14:08

Días Estadía: 12

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Convulsión

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Claudio Casanova Solano
RUT: 12502972-8
Edad: 50 años
FI HSR: 13/08/2023
FI SALA: 18/08/2023

ANTECEDENTES

Mórbidos: Absceso cerebral 05/2022 por S. anginosus con craniectomía descompresiva izquierda e instalación de DVE.

Quirúrgicos: 08/06 craniectomía descompresiva, drenaje de abscesos y DVE.

Alergias: (-)

Medicamentos: Levetiracetam 500 mg cada 12 horas.

Hábitos: TBQ IPA 8, OH (-), drogas niega.

Inmunizaciones: COVID 19 5 dosis, Flu +.

Social: Vive con hermano y familia en Pirque. Parcialmente independiente para ABVID (Camina asistido, come asistido), dependiente para AIVD. Tutor: hermano Carlos Casanova (+569 20096056).

ANAMNESIS PRÓXIMA

Consulta el día 13/08 en SAPU de Pirque por cuadro de 4 episodios convulsiones tónico-clónicas generalizadas con pérdida de control de esfínter. Durante evaluación clínica, presenta nuevo episodio convulsivo, se administra diazepam, y se deriva a SU CASR.

Ingresa a SU en regulares condiciones, normotenso, taquicárdico, bien perfundido a distal, vigil, desconectado del medio, con pupilas midriáticas. Destaca tos con expectoración durante examen físico. Se inicia lorazepam 2 mg EV y carga de 2 gramos de levetiracetam por SNG. Se hospitaliza para continuar estudio y manejo.

Familiar refiere deterioro funcional en los últimos meses, con inestabilidad progresiva de la marcha y mayores requerimientos de apoyo. Buena adherencia a fármacos, sin contusiones recientes ni caídas, sin fiebre, sin síntomas GI ni urinarios.

Al examen físico de ingreso destaca hemodinamia estable, afebril, taquicárdico, bien perfundido, con pupilas midriáticas, con desconexión con el medio, no emitiendo lenguaje. En lo neurológico: conecta, no emite lenguaje ni obedece órdenes, solo quejidos ocasionales, isocoria, RFM +/+, hemianopsia der por amenaza, mueca facial simétrica en reposo, moviliza las 4 EE al menos M3, reflejo plantar flex izq/equivoco der, sin movimientos involuntarios.

Fecha Epicrisis : 25/08/2023 17:04

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 25-08-2023 17:04:28

Página 2 de 4

ESTUDIO EN SERVICIO DE URGENCIA LABORATORIO

15/08: Crea 0.58 BUN 12.8 ELP 139/4.27/107 Alb 3.2 FA 49 GOT 27 GPT 11 GGT 16 pH 7.3 pCO2 39.7 pO2 50.3 HCO3 21.2 EB -4.5 PCR 24.6 TUS 18.2 Hcto 40.6 Hb 14 VCM 90.8 GB 9.240 PLQ 245.000 Láctico 12.2

13/08: Crea 0.71 BUN 10.3 ELP 137/4.43/106 pH 7.4 pCO2 35.9 pO2 78.6 HCO3 23.6 EB -0.1 Glicemia 107 LDH 496 Mg 2.4 PT 7.3 BT 0.4 BD 0.11 FA 52 GGT 18 GOT 30 GPT 11 Ca 8.8 Alb 3.7 Láctico 16.6 PCR 6.6 Hcto 43.5 Hb 14.9 VCM 90.3 GB 11.880 PLAQ 262.000 INR 0.92 TTPA 27.8

IMÁGENES

TAC de tórax 13/08: Signos de bronquiolitis celular de probable etiología inflamatoria - Infecciosa asociado secreciones traqueales y endobronquiales, de probable etiología aspirativa.

TAC de cerebro 13/08: Encefalomalacia occipital y temporal izquierdas conocidas, sin signos de migración transependimaria, no se observan lesiones compatibles con nuevos abscesos ni colecciones asociadas. Destaca menos hundimiento, sin signos de hidrocefalia. Surcos y cisternas presentes. (informado por NeuroCx)

EEG: Anormal Lentitud continua hemisférica izquierda. Atenuación de voltaje hemisférica derecha. Disfunción lenta continua generalizada.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO

Diagnósticos:

1. Neumonía aspirativa tratada y sospecha nuevo evento aspirativo (24/05)

- Ampicilina / sulbactam (FI: 24/08, en día 2/5)

- Ceftriaxona (14 a 21/08)

2. Deterioro funcional; motor y deglutorio progresivo

3. Desnutrición mixta

4. Crisis epiléptica en estudio resuelta

- Epilepsia estructural secundaria

5. Antecedentes: Absceso cerebral 05/2022 con craniectomía descompresiva izquierda e instalación de DVE.

EVOLUCIÓN EN SERVICIO DE URGENCIA Y EN SALA BÁSICA

1. Hemodinamia: evoluciona estable, sin requerimientos de drogas vasoactivas, hipotensores o monitorización invasiva.

2. Respiratorio: inicialmente con bajos requerimientos de oxígeno, que se suspenden precozmente. Requiere apoyo con kinesioterapia. El día 24/08 durante madrugada presenta episodio de desaturación, con requerimientos de aportes de oxígeno, que se suspenden precozmente. Se interpreta como fenómeno aspirativo. Evoluciona sin dificultad respiratoria ni conflicto en esta área, sin requerimientos de oxígeno, movilizándose secreciones con requerimiento de aspiración SOS.

3. Neurológico: Paciente con antecedente de abscesos cerebrales con craniectomía descompresiva, ingresa por convulsiones TCG por lo que se inicia carga y manejo con levetiracetam. Impresiona fuera de su basal, por lo que se decide mantener hospitalizado para estudio. Permanece sin nuevas crisis clínicas y con recuperación en su nivel de conciencia. Evaluado por Neurocirugía quienes indican sin patología de resorte quirúrgico actual. Se completa estudio con EEG que evidencia cambios compatible con lesiones estructurales. Se mantiene con levetiracetam 1 gr cada 12 horas con buena respuesta, sin nuevos episodios convulsivos. Al alta, realizar IC a CESFAM para tramitación por familiares y asegurar entrega del anticonvulsivante en APS.

4. Infeccioso: en contexto de síndrome convulsivo, ingresa al SU con síntomas respiratorios. Se realiza TAC de tórax que informa signos compatibles con neumonía aspirativa/traqueobronquitis, por lo que se inicia manejo con ceftriaxona/clindamicina el 14/08. En estudio microbiológico destaca panel viral y PCR SARS CoV2 negativo, HC y CAET, (P), UC (+) E. Faecium 100.000 UFC R Ampicilina - Nitrofurantoína - Vancomicina. Paciente sin síntomas urinarios, SO no inflamatoria, por lo que se interpreta como bacteriuria asintomática (se rescata e. faecium Van B R a ampi y Vanco, S Line y Tetra). Completa 7 días de ATB el 21/08, con buena respuesta clínica y en exámenes de laboratorio, con PPII a la baja. El día 24/08 en relación a fenómeno aspirativo equipo de turno inicia esquema ATB con ampicilina/sulbactam. En control de exámenes destaca leve elevación de GB, con PCR a la baja (posible inflamación por neumonitis asociada a aspiración). Se define completar 5 días de ATB dado evolución favorable.

PCR COVID 19 24/05: NEGATIVA

5. Rehabilitación: Paciente parcialmente independiente para ABVD, tutor refiere que durante últimos meses cursa deterioro progresivo de funcionalidad, con inestabilidad de la marcha y mayores requerimientos de apoyo por familiares. Con necesidad de rehabilitación por KNT motora y fonoaudiológica dado riesgo de aspiración, actualmente alimentándose de forma exclusiva con SNG dado eventos aspirativos. En plan de aumentar aportes por SNG hasta 70-80 ml/h de forma progresiva si buena

Fecha Epicrisis : 25/08/2023 17:04

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 25-08-2023 17:04:28

Página 3 de 4

tolerancia y según reevaluación por equipo de nutrición.

6. Hematológico: en control de exámenes de 25/08 destaca descenso de Hb (con Hb sobre 12), sin exteriorización de sangrados. En plan de seguimiento clínico y con celldyn seriados.

Se solicita traslado al Hospital de San José de Maipo para continuar rehabilitación motora y deglutoria. Paciente en buenas condiciones generales, afebril, sin requerimientos de oxígeno, tranquilo.

EXAMEN FÍSICO DE TRASLADO

Consciente, orientado en tiempo y espacio. Atento, cooperador, sigue indicaciones simples. Signos de craniectomía cerebral izq.

Bien hidratado y perfundido a distal.

Yugulares no ingurgitadas, no palpo adenopatías.

RR2tss, MP + SRA

Abdomen BDI, RHA +, calota palpable en flanco derecho

EEI sin edema, tibio a distal, enflaquecido, masa muscular disminuida.

Exámenes:

25/08: ELP 144/3.56/111, pH 7.36 PCO2 47 HCO3 26 Hb 12.6 GB 14.64 RAN 12.3 PLQ 272 ALb 3.2 Ca 8.9 Crea 0.56 BUN 21.2 P3.3 Mg 2.2 PreAlb 14.7 Prot T 14.9

24/08: ELP 146/3.81/106 pH 7.32 PCO2 42, HCO3 21, Hb 15, GB 13.81 RAN 12.4 PLQ 254 Crea 0.6 PCR 1.6 BUN 16

22/08: pH 7.48 PCO2 32.3 HCO3 23.7 Hb 14 GB 6.0 PLQ 314, ELP 141/3.78/104, VHS 7, PCR 1.3 BUN 16.9 Crea 0.57

19/08: Alb 3.1 Hepáticas normales, Ca 8.2, Crea 0.54, BUN 5.5 Glu 79 LDH 190 PreAlb 13.4 PT 5.8 PCR 4.2 CK total 222 CK MB 1.1 Hto 39.5 Hb 13.6 GB 5.43 RAN 3.0 PLQ 266 ELP 138/3.24/104 pH 7.40 PCO2 37.7 HCO3 22.9 EB -1.3

DIAGNÓSTICOS DE TRASLADO A HSJM

Neumonía aspirativa tratada

Trastorno motor y deglutorio en rehabilitación

Desnutrición

Crisis epiléptica resuelta

Antecedentes: Absceso cerebral 05/2022 con craniectomía descompresiva izquierda e instalación de DVE.

INDICACIONES GENERALES

Reposo en cama movilizar progresivamente por kinesiología

Régimen por SNG con osmolite a 50 cc/h

O2 para sat 92%

Rehabilitación multidisciplinaria por kinesiología, terapia ocupacional y fonoaudiología.

Aislamiento de contacto.

MEDICAMENTOS

Ampicilina/sulbactam: 3 g EV cada 6 horas por 4 días (FI 24/08)

Levetiracetam 1 g cada 12 horas vía SNG

Risperidona 1 mg: 1 comprimido vía SNG PM + 1 mg SOS

Tiamina 300 mg cada 8 horas EV

SOS:

Paracetamol 1 g cada 8 horas SOS si fiebre 38° o dolor vía SNG

Metamizol 1g SOS EV cada 8 horas si dolor o fiebre pese paracetamol

Lorazepam 2 mg EV SOS si crisis convulsiva 3 min duración

Enoxaparina 40 mg SC al día

CONTROLES:

En neurología CDT, solicitar control tras alta con epicrisis.

En Consultorio, solicitar hora, asegurar permanencia de tratamiento antiepiléptico y rehabilitación.

Urgencia SOS en caso de fiebre sobre 38°C, dificultad respiratoria, convulsiones, compromiso de conciencia, otros, según necesidad.

Diagnóstico de Egreso

Neumonitis debida a aspiración de alimento o vómito -

Condición de Egreso Traslado

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fecha Epicrisis : 25/08/2023 17:04

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:48

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 25-08-2023 17:04:28

Página 4 de 4

Traslado para rehabilitación. Hd estable, afebril, sin requerimientos de oxígeno

Plan Post Alta

En epicrisis

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles



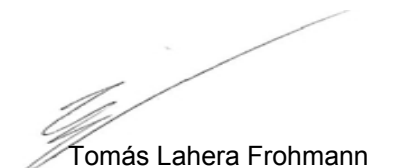
Bec. Ignacio Tellez Guzmán

BECADO



Bec. Ignacio Tellez Guzmán

Becado/Residente



Tomás Lahera Frohmann

Médico Tratante (Staff)